

OTITIS EXTERNA

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Libro Azul de Infectología Pediátrica 2011

Se denomina OE a cualquier infección del conducto auditivo externo. Puede ser un fenómeno local o parte de una infección generalizada de la piel (eccema, seborrea, atopía, psoriasis, histiocitosis).

Las OE de origen infeccioso se pueden clasificar como:

- OE difusa aguda: también conocida como "otitis de pileta".
- Forunculosis: es una infección focal de un folículo piloso de la piel del conducto auditivo externo.
- OE micótica.
- OE necrosante ("maligna"): osteomielitis de la base del cráneo.

Microbiología

La OE ocurre mayormente en el verano, cuando es frecuente que los niños pasen largas horas practicando natación.

El origen suele ser una infección bacteriana (80%) que a veces se suma a una dermatitis preexistente.

Los patógenos más frecuentes son:

- *Pséudomonas aeruginosa*: más frecuente
- *Staphylococcus aureus*
- Otros como *Enterococcus* y *Proteus mirabilis*
- Micosis: poco frecuentes (1%), el género *Penicillium* es el más común
- Rara vez virus (herpes zoster por ejemplo)

Estos patógenos contrastan con la flora normal del conducto auditivo externo, donde el 96% de la flora son los grampositivos (*S. epidermidis* y *coryneformes*).

Fisiopatología

El agua modifica el pH del conducto, lo lleva hacia la alcalinidad y suprime factores de protección local y de homeostasis.

Factores predisponentes

- Anatómicos: conductos delgados, exceso de cerumen y pelos.
- Humedad excesiva.
- Elevada temperatura.
- Traumatismos provocados al intentar limpiar el CAE.

Clínica

Los síntomas suelen ser poco orientadores como para distinguir OE de OMA.

La OE en lactantes es rara, suele observarse en niños mayores de 2-3 años cuando frecuentan los natatorios.

El dolor se incrementa al desplazar el pabellón auricular.

Ocasionalmente, puede palparse adenopatía preauricular dolorosa.

Se llega al diagnóstico a través de los signos clásicos: eritema y reducción del calibre del CAE por edema inflamatorio.

La visualización tímpano es difícil cuando existe OE, pero debe intentarse, ya que puede haber otorrea desde el oído medio o una OMA, lo que indica una "otitis mixta".

Tratamiento

La OE puede ser sumamente dolorosa y es importante recordar que la analgesia es una prioridad.

Tratamientos tópicos

- a. **Ácido acético:** las soluciones "antisépticas" de ácido acético tienen actividad antimicrobiana contra los patógenos comunes de la OE (*Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus*). Su eficacia depende de su capacidad para disminuir el pH del conducto. El pH bajo reduce el desarrollo de bacterias y hongos.
Puede provocar dolor al contactar la piel inflamada y causar ototoxicidad si llega al oído interno. Recientemente, se comprobó que el ácido acético causaba más daño coclear en situaciones crónicas, que las gotas antibióticas.
- b. **Alcohol boricado:** aplicar 2 gotas, 3 veces al día, inclinar la cabeza hacia el lado contrario al oído a tratar, y a continuación, dejar caer las gotas
- c. **Antimicrobianos tópicos:** comparados con los antibióticos orales, los tópicos son más eficaces y reducen las recurrencias, porque se aplican directamente sobre las bacterias en el conducto, a concentraciones que superan ampliamente el CIM requerida para la erradicación.
 - Aminoglucósidos: muchos prefieren evitar el riesgo de oto-toxicidad eventual de los. Gradualmente.
 - Ofloxacina o ciprofloxacina: son eficaces como monoterapia y no se han observado efectos indeseables.Si el edema impide la colocación de gotas, se puede introducir una mecha fina de gasa que permita llegar al fondo del conducto con la solución apropiada.
 - Corticosteroides: Pocos trabajos rigurosos comprueban el beneficio de los corticoides tópicos asociados al antibiótico. Pistorius, al comparar ciprofioxacina sola contra ciprofioxacina más hidrocortisona para la OE, demostró una respuesta más rápida al dolor (otalgia), cuando se empleaba esta combinación.

Se puede insertar una mecha en el conducto auditivo y aplicar gotas tópicas sobre ella 3 veces al día durante 24 a 48 hs.

Antimicrobianos sistémicos

Rara vez son necesarios, salvo que la OE sea persistente o se asocie con OMA (otitis mixta). Cuando se extiende más allá del conducto existe dolor intenso, desproporcionado a los hallazgos clínicos y fiebre elevada.

En ese caso, o cuando el paciente presenta factores agravantes (desnutrición, trastornos inmunológicos), deben usarse antibióticos sistémicos.

Medidas de prevención y control

Deben evitarse los factores predisponentes y tratarse las dermatosis del conducto.

La natación se postergará hasta que el paciente esté curado o se adoptarán medidas para que el conducto no se moje.

Las gotas de alcohol boricado o de ácido acético suelen ser eficaces como preventivo después de las sesiones de natación prolongadas.

También puede utilizarse un secador de pelo para eliminar la humedad del oído después de nadar.